

Где искусственный интеллект приносит пользу — и где ему нельзя

Для Наума · 18 августа 2026 · подготовил Michael + Joseph (Claude)

Коротко

ИИ в Bearing нужен не для того, чтобы «отвечать пациенту». Он нужен, чтобы правильно читать официальные реестры и находить пациенту то, что мы сейчас пропускаем. Ответ пациенту по-прежнему формирует наш код, а текст ограничений цитируется дословно из реестра. Это не осторожность ради осторожности — это то, что удерживает продукт вне регуляторной категории «медицинское изделие».

Почему граница важнее самой идеи

Обещание Bearing — «мы цитируем реестр, мы его не интерпретируем». Как только ИИ начинает решать «вам это подходит», продукт по европейскому регламенту MDR превращается в медицинское изделие, а по AI Act — в систему высокого риска. Это означает орган по сертификации, клиническую оценку и совсем другие сроки и бюджет. Поэтому ИИ у нас работает до ответа пациенту, а не вместо него.

Что ИИ делать НЕ будет	Почему
Решать, положен ли пациенту препарат	Это клиническое решение. Отдаём его врачу и плательщику — как сейчас.
Переписывать или пересказывать текст ограничения	Пересказанное ограничение — уже другое ограничение. Цитируем дословно.
Формировать сам ответ «доступно / недоступно»	Это делает наш код по понятным правилам, которые можно проверить и объяснить.
Обучаться на данных OncoKB	Прямо запрещено лицензией OncoKB.

Почему это срочно — реальный случай

Мой разбор текста ограничений регулярными выражениями перепутал смысл на обратный: часть листингов PBS требует отсутствия мутаций EGFR и ALK, а мой код записал их как требуемые. Я поймал это глазами на 61 листинге. На 5 000 листингов и четырёх странах глазами это не ловится. Именно здесь ИИ окупается — и именно здесь его результат легко проверить, потому что рядом всегда лежит исходный текст.

Где ИИ приносит пользу — по приоритету

Задача	Что даёт	Риск
--------	----------	------

1. Разбор текста ограничений в структуру	Точность там, где мы сейчас ошибаемся. Каждое извлечённое поле ссылается на предложение-источник.	Низкий — проверяемо
2. Сопоставление пациента с листингами	Сейчас это подстрока плюс ручное правило для НМРЛ. Для редких болезней (11 645 диагнозов Orphanet) не работает вовсе.	Низкий — только расширяет
3. Объяснение изменений	Когда формулировка меняется — сказать простым языком, что именно сдвинулось. Прямо питает движок уведомлений.	Низкий
4. Чтение загруженных документов	Вытащить «EGFR exon 19 del» из PDF-заключения и подставить в профиль. Снимает самый тяжёлый шаг онбординга.	Средний — нужны согласие и DPA
5. Вопросы к приёму у врача	«Спросите, делали ли вам тест на ROS1 — от него зависят два оплачиваемых варианта».	Низкий

Ключевое правило безопасности для пункта 2: ИИ расширяет сеть, но никогда её не сужает. Он может предложить показать листинг — он не может ничего скрыть. Ложное срабатывание стоит пациенту одного взгляда; пропуск стоит месяцев.

Про статистику — честно

Пациентов у нас пока нет, и статистика по пациентам была бы выдумкой. Но в данных, которые мы уже держим, есть настоящий материал: сколько дней проходит от одобрения TGA до включения в PBS по каждому препарату; как часто ограничения смягчаются, а как часто ужесточаются; по каким диагнозам покрытие самое тонкое.

Это публикуемо, на это ссылаются — и это именно тот аргумент для страховых. Страховой компании «доступ меняется в среднем через N дней после одобрения» интереснее, чем кабинет одного пациента. Цифры даёт SQL; ИИ помогает их описать, а не придумать.

Что предлагаю сделать первым

Пункт 1 — разбор в структуру, с проверкой человеком. Причины: исправляет ошибку, которая уже доказана; результат полностью сверяется с дословным текстом; ИИ при этом никогда не разговаривает с пациентом напрямую; и это фундамент, на котором стоит улучшенное сопоставление.

Стоимость незначительна: 61 листинг — это несколько центов, 5 000 — пара долларов, один раз, дальше только при изменениях.

Первый шаг — эксперимент на один проход

Прогнать текущие 61 листинг PBS через извлечение и сравнить результат с тем, что дал мой разбор регулярными выражениями. За один проход мы увидим, сколько он делает правильно — и, что важнее, сколько ошибается, ещё до того, как это увидит хоть один пациент.

Что нужно, чтобы начать: ключ Anthropic API. Без него код можно написать, но нельзя проверить — а непроверенный код в этом продукте мы не выпускаем.